Клинические рекомендации

Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J31.1** — Хронический назофарингит **J35.1** — Гипертрофия миндалин **J35.2** — Гипертрофия аденоидов **J35.3** — Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов **J35.8** — Другие хронические болезни миндалин и аденоидов
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/662_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Причины 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

2.5 Жалобы и анамнез 4

3. Диагностика 4

3.1 Осмотр 5

3.2 Инструментальные исследования 5

3.3 Чего не делать 5

3.4 Консультации специалистов 5

4. Лечение 6

4.1 Хирургическое лечение 6

4.2 Консервативное лечение аденоидита 7

4.3 Обезболивание после операции 8

4.4 После операции 8

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 8

5.1 Профилактика 8

5.2 Госпитализация и выписка 9

5.3 Что влияет на результат 9

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности в самом тексте КР 9

1. Главное

- Сами по себе глоточная и нёбные миндалины у ребёнка — не патология. Обследование начинают из-за жалоб, клинических проявлений или сопутствующей болезни, на течение которой могут влиять аденоиды и миндалины.
- Гипертрофию нёбных миндалин диагностируют по жалобам, анамнезу и фарингоскопии с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин, а гипертрофию аденоидов — только с инструментальным подтверждением: эндоскопией носоглотки, рентгенографией носоглотки или КТ.
- Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей не проводят.
- При наличии показаний аденоиды и миндалины оперируют в плановом порядке; если показаний нет или есть абсолютные противопоказания, пациента динамически наблюдает оториноларинголог.
- Детей с гипертрофией аденоидов лечат консервативно только при признаках аденоидита. У детей младше 7–9 лет, если нет осложнений и заметного влияния на качество жизни, аденоидит не считают патологией и ограничиваются наблюдением.

2. Клиника и классификация

2.1 Определения

Гипертрофия аденоидов — увеличение глоточной миндалины со стойким затруднением носового дыхания и (или) другими осложнениями: обструктивными нарушениями сна, экссудативным средним отитом, деформацией лицевого скелета. Гипертрофия нёбных миндалин — увеличение одной или обеих нёбных миндалин; она может протекать бессимптомно или проявляться храпом, остановками дыхания во сне, нарушениями глотания и артикуляции, деформацией лицевого скелета.

Аденоидит — реактивные воспалительные изменения глоточной миндалины как органа местного иммунитета слизистых в ответ на антигены, попадающие на слизистую носа и глотки. У детей младше 7–9 лет без заметного влияния на качество жизни и без осложнений, например средних отитов, его не считают патологией.

Рецидивирующим острым синуситом называют 4 эпизода и больше за последний год. Рецидивирующий острый средний отит — 3 эпизода и больше за 6 месяцев или 4 и больше за 12 месяцев.

2.2 Причины

Наиболее вероятными причинами считают вирусную инфекцию, генетическую предрасположенность и влияние окружающей среды. Роль бактериальной инфекции, гастроэзофагеального рефлюкса и аллергии спорна. Обычно действует сразу несколько факторов, и выделить ведущий не удаётся.

Особое внимание уделяют вирусу герпеса IV типа: герпетическая инфекция — одна из частых причин выраженной гипертрофии глоточной миндалины со стойкой обструкцией носоглотки.

2.3 Классификация

Для аденоидов в России чаще всего используют классификацию А. Г. Лихачёва — по тому, какую часть сошника прикрывает ткань глоточной миндалины. При I степени она прикрывает не больше верхней трети сошника, при II — от 1/3 до 2/3, при III — больше 2/3.

Для нёбных миндалин чаще всего используют классификацию Б. С. Преображенского. Расстояние между вертикалью через середину язычка и линией по краю передней (нёбно-язычной) дужки делят на три части. При I степени миндалина занимает треть этого расстояния, при II — две трети, при III миндалины доходят до язычка и соприкасаются друг с другом.

2.4 Клиническая картина

Жалобы и симптомы чаще всего бывают при гипертрофии III степени. При I и II степени пациенты обычно, хотя и не всегда, ни на что не жалуются.

При гипертрофии нёбных миндалин родители обычно жалуются только на храп. В отличие от храпа при воспалении, он постоянный и часто не зависит от позы во сне. Иногда родители замечают и классические признаки синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): дневную сонливость и снижение успеваемости. Значительно реже бывают изменения прикуса и лёгкая дисфония.

При гипертрофии аденоидов, в том числе в сочетании с увеличением нёбных миндалин, жалобы разнообразнее. Кроме нарушений дыхания во сне, беспокоят стойкое затруднение носового дыхания и его следствия — постоянно открытый рот, гипоназальность (закрытая гнусавость), сухость во рту. Нередко снижается слух из-за экссудативного среднего отита или в анамнезе есть повторные острые средние отиты. Даже при II степени ринологические симптомы — заложенность носа, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель — после простуды могут держаться до нескольких недель. У школьников с аденоидами часто бывают острые синуситы, в том числе рецидивирующие.

При аденоидите главная жалоба — кашель, обычно продуктивный, ночной и утренний: это проявление постназального синдрома, то есть стекания отделяемого по задней стенке глотки. Аденоидит бывает и при небольшой глоточной миндалине. При аденоидите на фоне гипертрофии аденоидов II–III степени обычно одновременно жалуются на заложенность носа и кашель.

Реактивные изменения глоточной миндалины после простуды или на фоне аллергического ринита у детей младше 7–9 лет физиологичны. Патологией их не считают, если нет осложнений (средних отитов, острого синусита) и симптомы — кашель или затруднённое носовое дыхание — не нарушают сон и дневную активность ребёнка.

Симптомы гипертрофии аденоидов и аденоидита не патогномоничны. Их отличают от острого и хронического риносинусита, аллергического, вазомоторного и гипертрофического ринита, искривления перегородки носа, инородных тел и новообразований полости носа и носоглотки. Гипертрофия аденоидов часто сопутствует острому и хроническому синуситу и аллергическому риниту.

У взрослых симптомы те же, что у детей.

2.5 Жалобы и анамнез

Уточняют, сколько длится болезнь, с чем пациент связывает её начало, как менялись жалобы и как они влияют на сон и повседневную активность ребёнка, какое было лечение, его эффект и нежелательные явления. Важно, есть ли симптомы вне эпизодов острых респираторных инфекций, и насколько они выражены сейчас по сравнению с прошлым. Из анамнеза жизни выясняют сопутствующие болезни, прежде всего аллергию: наблюдается ли по ним ребёнок у специалиста, как лечится, планируются ли операции. Большое значение имеют перенесённые операции и манипуляции в полости носа, включая назотрахеальную интубацию и любые назальные зонды.

3. Диагностика

Наличие у ребёнка глоточной и нёбных миндалин — не патология. Обследование оправдано, если есть жалобы, клинические проявления или сопутствующая болезнь, на течение которой могут влиять аденоидит, гипертрофия аденоидов или нёбных миндалин.

Гипертрофию нёбных миндалин диагностируют по жалобам, анамнезу и физикальному обследованию — фарингоскопии с обязательной оценкой нижнего полюса миндалин. Для диагноза гипертрофии аденоидов, кроме этого, нужно инструментальное исследование: эндоскопия носоглотки, рентгенография носоглотки или компьютерная томография (КТ).

3.1 Осмотр

Всех пациентов осматривает оториноларинголог, чтобы оценить общее состояние, выраженность симптомов и сопутствующую патологию, — и амбулаторно, и при госпитализации в ЛОР-отделение.

Пальцевое исследование носоглотки для диагностики аденоидов у детей в амбулаторной практике не проводят: его результаты крайне субъективны, процедура неприятна ребёнку и может травмировать структуры глотки.

Лабораторные исследования для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин не используют; они нужны только для диагностики сопутствующих болезней.

3.2 Инструментальные исследования

При симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, проводят эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки.

Если эндоскоп гибкий и изображение можно сохранить на фото или видео, это наиболее предпочтительный метод. Эндоскопия носоглотки — метод первого выбора для дифференциальной диагностики и для оценки носоглотки после операции, в том числе в отдалённые сроки. Ригидный эндоскоп ребёнок, особенно дошкольник, переносит хуже, а осмотр без сохранения изображения значительно менее объективен для последующих консультаций.

Рентгенографию носоглотки в боковой проекции делают при симптомах, характерных для гипертрофии аденоидов, чтобы оценить размер глоточной миндалины.

Метод дешёвый, доступный и безболезненный. Минусы — небольшая лучевая нагрузка, необходимость правильной укладки с открытым ртом и невозможность отличить аденоиды от других объёмных образований носоглотки; результат не всегда соответствует выраженности симптомов. После аденотомии рентгенография малоинформативна: аденоиды нельзя отличить от компенсаторной гипертрофии трубных валиков и нельзя оценить рубцы.

КТ верхних дыхательных путей и шеи делают не всем, а по специальным показаниям — в сложных случаях, когда нужно отличить гипертрофию аденоидов от другой патологии носа с похожими симптомами или диагностировать их одновременно.

При гипертрофии аденоидов проводят тимпанометрию, чтобы объективно оценить состояние среднего уха.

3.3 Чего не делать

Мазки из глотки на микрофлору для диагностики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин у детей не берут. Условно-патогенные бактерии часто есть в глотке и у здоровых людей, поэтому ни рост, ни отсутствие роста при отсутствии признаков бактериальной инфекции не позволяют оценить риск и прогноз.

3.4 Консультации специалистов

По специальным показаниям пациента направляют к аллергологу-иммунологу, чтобы подтвердить или исключить сопутствующую аллергию и согласовать лечение. Направляют планово при клинических и анамнестических признаках аллергического ринита, атопической бронхиальной астмы или атопического дерматита.

В первую очередь консультация нужна при глазных симптомах или повторном чихании и зуде в носу; при ринологических симптомах, которые пациент связывает с цветением, животными или другими определёнными ситуациями; при повторных приступах кашля, свистящего или затруднённого дыхания и стеснения в груди, особенно ночью и рано утром; при кожных проявлениях атопического дерматита, крапивницы и других аллергических болезней кожи; при рецидивирующих острых средних отитах или риносинуситах.

При признаках повторяющихся обструктивных нарушений сна пациента по возможности планово направляют к специалисту по расстройствам сна для объективной диагностики и согласования лечения.

При врождённых или приобретённых изменениях челюстно-лицевой области пациента планово направляют к ортодонту.

По специальным показаниям пациента направляют к инфекционисту для диагностики персистирующих вирусных инфекций, прежде всего герпесвирусной.

Показание — хотя бы один из признаков, который держится 3 месяца и дольше: увеличение лимфоузлов в 3 группах и более (не меньше 3 узлов в каждой); увеличение печени и (или) селезёнки; снижение абсолютного числа нейтрофилов в анализе крови ниже возрастной нормы и (или) общего числа нейтрофилов ниже 5×10^9/л. Оториноларинголог только оценивает симптомы, а решение о лабораторном поиске вирусов принимает инфекционист.

4. Лечение

При наличии показаний гипертрофию аденоидов и нёбных миндалин лечат хирургически в плановом порядке. Если показаний нет или есть абсолютные противопоказания, пациента динамически наблюдает оториноларинголог. При хронической или врождённой сопутствующей патологии операцию проводят только по согласованию с профильным специалистом.

Абсолютные противопоказания к операции — шок, острая стадия инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения, поздние стадии тяжёлых инфекционных и онкологических болезней, тяжёлое, крайне тяжёлое или терминальное состояние из-за сопутствующих болезней. Относительные — неконтролируемое или плохо контролируемое течение сопутствующей соматической патологии и аномалии строения носа, резко повышающие риск серьёзных осложнений во время операции.

Консервативное лечение оправдано только при клинических и анамнестических признаках воспаления глоточной миндалины (аденоидита) или нёбных миндалин (тонзиллита), если есть соответствующие жалобы или осложнения.

4.1 Хирургическое лечение

Аденотомию при гипертрофии аденоидов делают по специальным показаниям, чтобы восстановить проходимость носоглотки, и только при отсутствии противопоказаний.

Показания у детей: частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, иногда с дневной сонливостью и вялостью); экссудативный средний отит, который не проходит 3 месяца, не поддаётся консервативному лечению и подтверждён тимпанометрией; рецидивирующие острые средние отиты или острые синуситы (3 эпизода и больше за 6 месяцев или 4 и больше за 12 месяцев), если исключены другие причины, прежде всего иммунодефицит, а медикаментозная профилактика не помогла; хронический синусит с выраженными симптомами или частыми обострениями, если не помогли 1–2 курса консервативного лечения; стойкое затруднение носового дыхания без других причин, которое ухудшает качество жизни или ведёт к деформации лицевого скелета по данным цефалометрии и заключению ортодонта или челюстно-лицевого хирурга; заключение других специалистов, что аденотомия нужна как этап лечения сопутствующей болезни, например перед кардиохирургической операцией.
Если обструктивные нарушения сна можно оценить объективно, ориентируются на индекс апноэ-гипопноэ: от 5 до 15 — среднетяжёлая форма, больше 15 — тяжёлая.
Детям аденотомию предпочтительно делать под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Тонзиллотомию детям с гипертрофией нёбных миндалин делают по специальным показаниям, чтобы уменьшить миндалины. Основное показание — частые или регулярные эпизоды обструктивных нарушений сна (храп, иногда с дневной сонливостью и вялостью); при возможности ориентируются на индекс апноэ-гипопноэ, как при аденотомии.

Если у ребёнка одновременно есть показания и к тонзиллотомии, и к тонзиллэктомии, лучше сделать тонзиллэктомию. Тонзиллотомию предпочтительно проводить под общим обезболиванием в ЛОР-отделении стационара или в стационаре кратковременного пребывания.

Если увеличены и аденоиды, и нёбные миндалины, аденотомию делают вместе с тонзиллотомией по тем же показаниям, что и аденотомию.

Такую операцию проводят только под общим обезболиванием с обязательным визуальным контролем операционного поля, а в раннем послеоперационном периоде пациента наблюдают в ЛОР-отделении стационара.

Взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и синдромом обструктивного апноэ сна при отсутствии противопоказаний делают тонзиллэктомию, чтобы уменьшить симптомы апноэ.

> У рекомендации о тонзиллэктомии взрослым не указаны ни уровень убедительности, ни уровень достоверности доказательств. Кроме того, разделы о госпитализации, послеоперационном обезболивании и реабилитации говорят только об аденотомии и тонзиллотомии, а о тонзиллэктомии у взрослых не упоминают.

4.2 Консервативное лечение аденоидита

Консервативно лечат детей с гипертрофией аденоидов только при признаках аденоидита: продуктивном кашле из-за постназального затёка, выделениях из носа, периодическом затруднении носового дыхания. Если у ребёнка младше 7–9 лет нет заметного влияния на сон, еду и повседневную активность и нет осложнений, например средних отитов, это не патология, и врач ограничивается наблюдением.

Всем пациентам с аденоидитом назначают ирригационно-элиминационную терапию — промывание полости носа.

Нос орошают 1–2 раза в день изотоническими или гипертоническими (1,5–3%) солевыми растворами на основе морской воды: это облегчает туалет носа, уменьшает симптомы и улучшает условия для последующих местных лекарств. Детям дошкольного возраста не промывают нос большими объёмами раствора из-за высокого риска средних отитов.

По специальным показаниям при аденоидите назначают местные антибиотики, чтобы подавить условно-патогенную флору носоглотки.

Применяют назальный спрей фрамицетина, детям старше 2,5 года — комбинированный препарат дексаметазон + неомицин + полимиксин B + фенилэфрин, или раствор для ингаляций тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат. Курс короткий, до 7 дней. Показание — признаки бактериальной инфекции: слизисто-гнойные выделения из носа и по задней стенке глотки в течение всего дня или отсутствие улучшения за 7–10 дней противовоспалительной терапии.
Растворы антибиотиков для парентерального, внутриконъюнктивального или ушного введения в нос не вводят: они не предназначены для полости носа и могут нарушить мукоцилиарный транспорт.

Пациентам старше 2 лет с аденоидитом назначают отхаркивающие муколитики, чтобы уменьшить постназальный затёк. Подходят только препараты с преимущественно мукорегулирующим действием; оптимальным в КР назван карбоцистеин.

Карбоцистеин в сиропе, в том числе в виде карбоцистеина лизина моногидрата, назначают курсом от 1 до 3 месяцев. Он уменьшает постназальный затёк и повышает вероятность разрешения сопутствующего экссудативного среднего отита. При монотерапии отличие от выжидательной тактики становится заметным только ко 2–3-й неделе. Одновременно другие муколитики, в том числе местные, не назначают, чтобы не усилить затёк.

Детям старше 2 лет с аденоидитом и сопутствующим аллергическим ринитом назначают топические глюкокортикостероиды: #мометазон в виде назального спрея по 1 дозе (50 мкг) в каждый носовой ход 1 раз в сутки (100 мкг в сутки) курсом от 1 до 3 месяцев.

Ни гипертрофия аденоидов, ни аденоидит, ни назофарингит не зарегистрированы в России как показание ни для одного местного глюкокортикостероида; знак # означает применение вне инструкции.

Масла, в первую очередь масло туи, при гипертрофии аденоидов и аденоидите не применяют: их эффективность не доказана, а в носу они угнетают работу ресничек, нарушают эвакуацию секрета и повышают риск бактериальной инфекции.

Ежедневно промывать нос растворами антисептиков не рекомендуется: эффективность не доказана, нарушается мукоцилиарный транспорт и возможны местные дисбиотические изменения.

4.3 Обезболивание после операции

При боли после аденотомии и (или) тонзиллотомии назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или парацетамол. Обезболивают при жалобах на боль или других её проявлениях — отказе от еды и питья, повторной рвоте и тошноте.

Препарат	Доза у детей
Ибупрофен	8–10 мг/кг на приём, не больше 30 мг/кг в сутки, внутрь в форме по возрасту (таблетки, покрытые оболочкой, — с 6 лет); младшим детям — ректальные суппозитории.
Кетопрофен	С 6 лет — гранулы для приготовления раствора для приёма внутрь (кетопрофена лизиновая соль), 40 мг на приём до 3 раз в день.
Парацетамол	10–15 мг/кг на приём, не больше 60 мг/кг в сутки, в любой форме по возрасту. Если принимать внутрь нельзя, а свечей нет, — парентерально 15 мг/кг на введение.

4.4 После операции

После аденотомии и (или) тонзиллотомии оториноларинголог осматривает пациента перед выпиской и амбулаторно через 7–14 дней после выписки, чтобы оценить состояние и исключить поздние послеоперационные осложнения.

В течение 5–7 дней после операции соблюдают охранительный режим.

Он включает ограничение контактов (без детского коллектива и людных мест), ограничение физической нагрузки и исключение перегрева, особенно головы и шеи, в том числе отказ от горячей еды и питья.

Если дисфония сохраняется больше месяца после операции, пациента направляют к логопеду-дефектологу.

Если симптомы обструктивных нарушений сна сохраняются больше 6–8 недель после операции, пациента направляют к специалисту по расстройствам сна.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

5.1 Профилактика

Специфической профилактики гипертрофии аденоидов и нёбных миндалин нет. Поскольку важную роль играют респираторные вирусы, соблюдают общие правила профилактики ОРВИ. Некоторые лекарства можно использовать для плановой и экстренной профилактики аденоидита у детей.

Детям старше 1 года из групп риска по респираторным инфекциям назначают стандартизированные растительные препараты для приёма внутрь из группы прочих антисептиков, чтобы предупредить эпизоды ОРВИ и сделать последующие эпизоды аденоидита короче и легче.

Это препараты с корнем алтея, цветками ромашки, хвощом, листьями грецкого ореха, тысячелистником, корой дуба и одуванчиком лекарственным. Их назначают и для лечения аденоидита при появлении симптомов ОРВИ — отдельно или в комплексе.

Детям старше 3 лет при появлении симптомов острого назофарингита назначают комбинированный препарат лизоцим + пиридоксин, чтобы последующий аденоидит был короче и легче.

Детям из групп риска по респираторным инфекциям назначают лизаты бактерий (другие иммуностимуляторы), чтобы эпизоды аденоидита и его осложнений были короче и легче.

Обычно это плановая профилактика курсами по инструкции 2–3 раза в год; подходят и формы для приёма внутрь, и местные.

Для профилактики аденоидитов и их осложнений у детей можно рассмотреть местные пробиотики на основе бактерий нормальной микрофлоры глотки.

В информации для пациента КР советует обратиться к врачу, если после простуды у ребёнка появились и в течение 2 недель не проходят заложенность носа, храп, снижение слуха или кашель (когда исключена патология нижних дыхательных путей).

5.2 Госпитализация и выписка

Госпитализируют для плановой аденотомии и (или) тонзиллотомии при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. Аденоидит лечат амбулаторно или в консультативно-диагностическом отделении. Выписывают после операции при удовлетворительном общем состоянии и отсутствии осложнений.

5.3 Что влияет на результат

При хронических соматических болезнях после аденотомии и (или) тонзиллотомии возможно их обострение в раннем послеоперационном периоде. Аллергический ринит повышает вероятность, что назальные симптомы — передняя и задняя ринорея, меньше заложенность — не пройдут полностью. Ожирение повышает вероятность сохранения обструктивных нарушений сна после операции. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь повышает вероятность сохранения назальных симптомов и риск инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде.

При гипертрофии нёбных миндалин лекарственное лечение аденоидита очень мало помогает избавиться от обструктивных нарушений сна.

Если у ребёнка есть сопутствующая болезнь, которая может повлиять на результат операции, врач должен сказать об этом пациенту или родителям до операции.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия нёбных миндалин»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	662_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Рекомендация о тонзиллэктомии взрослым с гипертрофией нёбных миндалин и СОАС дана без уровня убедительности и уровня достоверности доказательств, а разделы о госпитализации, обезболивании и реабилитации упоминают только аденотомию и тонзиллотомию.
- Для хронического аденоидита в разделе 1.4 предложены два кода: J31.1 («как возможный вариант кодирования») и J35.8 («например, аденоидит»).
- Растительные препараты рекомендованы в разделе профилактики, но в комментарии к ним сказано, что их назначают и для лечения аденоидита при симптомах ОРВИ.

- В комментарии к ибупрофену фраза о суппозиториях оборвана: «ректальные суппозитории (у детей младше) 2 лет»; возрастная граница неоднозначна.
- В рекомендации об осмотре после операции пропущено слово: «через 7-14 после выписки» — по смыслу дней.
- Сведения о незарегистрированных показаниях для мометазона даны «на конец 2020 года», хотя КР утверждены в 2024 году.
- В разделе профилактики есть ссылка «см. КР 25» без пояснения, о каких рекомендациях речь.